

心房顫動的用藥指南

為什麼需要同時使用兩種不同作用的藥物？

因為心房顫動會帶來「血栓中風」與「心跳紊亂」兩大問題



掃描看電子版



心房顫動：心房在「發抖、漏電」

心房無法規律收縮，血液流動變慢，可能形成血栓；心跳也可能忽快忽慢，讓人心悸、喘、疲倦，長期可能增加心臟負擔。

所以需要兩種「分工不同」的藥物，分別處理兩個風險。



問題一：血栓與腦中風

抗凝血劑負責「防堵塞」



血流變慢

形成血栓

堵住腦血管

為什麼要吃抗凝血劑？

降低血液形成血栓的能力，減少血栓跑到腦部造成缺血性腦中風的風險。

保護重點：大腦

沒有心悸，也不代表可以自行停藥。



主要安全提醒

異常出血、黑便或撞頭須儘快就醫



問題二：心跳紊亂

心跳與節律藥負責「穩心跳」



心跳亂 / 過快

心臟較費力

節律較穩定

為什麼要吃心跳 / 節律的藥？

控制心跳速度：讓心跳不要太快；

維持節律：用藥物幫助恢復規律心跳。

保護重點：心臟與生活品質

藥物選擇依心臟狀況及檢查結果而定。



主要安全提醒

昏倒、胸痛、喘加劇或心跳過慢要就醫

兩種藥都要記得



固定時間服用

漏服勿吃雙倍



新藥先詢問

包含成藥與保健品



不可自行停藥

手術拔牙前也先詢問

出血不止、昏倒、胸痛、呼吸困難或中風症狀：立即打 119

依亞太心律學會指引，亞洲病人的三個重點

- ① 抗凝血劑優先使用新型口服藥
- ② 不可自行減量 —— 減量不會比較安全
- ③ 阿斯匹靈不能取代抗凝血劑，單吃阿斯匹靈無法預防心房顫動造成的中風